

Finalement, le mouvement du développement du cerveau va nous donner vraiment un sens, je pourrais dire, à l'ostéopathie crânienne. Je peux dire ça comme ça. Que le corps, il a bien fait, il connaît bien. Et donc, on va simplement, c'est lui qui va vous instruire dans les chemins. Ce n'est pas vous qui allez réinstruire le cerveau, il connaît le chemin. Mais quelque part, il a en lui cette espèce de route. Et donc, on va apprendre à faire le tai-chi du cerveau. On va voir que la base du crâne est dépendante du cerveau. On va voir que tout le système de mise en place, le système ventriculaire, fluide profond du cerveau, est dépendant du mouvement dynamique du cerveau, et on va voir que tout le système membraneux, donc toutes les membranes de tension, faux du cerveau, tendu du cervelet, faux du cervelet, les membranes durmériennes, pariétales, viscérales, tout ça, toute cette compartimentalisation du cerveau, on va dire, seront dépendantes de nouveau de la dynamique de ce cerveau. Depuis, on pourrait dire, la structure dense qui va se situer sur le plan de la base du crâne, jusque sur la voûte, la prochaine fois, on revoit, c'est-à-dire qu'on va étudier essentiellement le viscérocrâne. On voit que le septum transversal, elle est donnée aussi, une partie, enfin, intégrée de tissus, donc le cœur, diaphragme, et ça se continuait avec le ligament falciforme. Donc on a une intégration déjà entre le cœur et le foie, dans leur fonctionnement. Ça se continuait, encore derrière, via le liatus de Winslow et tout le grand mouvement pour former le grand épip... Ça veut dire qu'on a une relation entre le cœur, le diaphragme, le cerveau et le système immunitaire, Donc ça veut dire que le cœur ou la base du crâne peut déstabiliser un système immunitaire. D'ailleurs, le système immunitaire le plus haut, c'est le système des tonsilles, avec l'anneau de Wellmire-Heller qui va se situer là-haut. Ça veut dire que si tu as une dysfonction qui va se retrouver ici, tu vas même voir que sur un plan, tout dépend de la fréquence que tu te mets, si tu te mets sur un plan moléculaire, tu vas voir que beaucoup d'enfants qui ont

des problèmes ORL, finalement tu vas retrouver sur un plan moléculaire la même immunoglobuline, c'est-à-dire l'immunoglobuline de type 1, je crois, qui va se retrouver sur le plan sécal. C'est-à-dire qu'une déstabilisation du péritoène peut déstabiliser en fait toute la sphère ORL. En d'autres mots, ça veut dire que sur un plan pratique, pour rééquilibrer une sphère ORL, il faut rééquilibrer un péritoène, et plus spécifiquement un niveau sécal, qui contient sur le plan appendiculaire des tissus lymphatiques, qui sont exactement les mêmes. D'ailleurs à l'époque, il y a une période où on coupait les amygdales et on coupait les appendicites. Et ça se fait dans des synchrones, des mouvements synchrones, tu vois, qui vont se développer. De plus, tu as tout ce qui est la relation maintenant oesophagienne, donc on voit que cette mésenchymes oesophagien, c'est ce qu'on a fait hier, peut perturber le fonctionnement du diaphragme. Donc ça veut dire que l'estomac, l'œsophage, suspendu jusqu'à la base du crâne, via ce qu'on appelle les forêts carotidiens, les plexus ptérégoïdiens, et jusqu'au niveau même des ptérégoïdes là-haut, est suspendu. Donc toute déstabilisation de ta base du crâne peut perturber la fonction cardio-tuberositaire. et donc perturber le mouvement diaphragmatique, qui est un mouvement très important. Tu as encore une autre chose aussi importante, c'est ce qu'on appelle la paroi mésoblastique, la paroi latérale. Ça veut dire que toute la grille costale est complètement sous la dépendance du bon fonctionnement de ton diaphragme. Donc ça veut dire que toute la zone dorsale sera dépendante de ça. De plus, par rapport à ça, on a vu qu'il y avait une jonction par rapport au Rhin, par rapport au Psoas, donc par rapport au Rhin, et donc par rapport à ton diodénome. Donc ça montre que c'est une intégrité globale. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit apprendre à travailler ce diaphragme plus qu'on le croit, avec plus de subtilité, à distance ou pas, et que si on arrive à expanser ce diaphragme, tu améiores la qualité de la vie. Autant je me suis

senti bien avec la référence de la motocorne pour le premier exercice, tu nous avais expliqué la porte ouverte après le point mobile, après le point zéro qui forme un. Autant là, dans le diaphragme, je n'ai pas senti de référence sur laquelle me poser, à part la motocorne finalement, pour retrouver cette unité dans mon centrage et le travail. Je pense que le premier point de référence que tu dois avoir, c'est essayer de retrouver le point d'appui du diaphragme. J'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait suspendre ce point d'appui à l'immobilité dynamique de l'espace. C'est comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc si c'est une porte qui s'ouvre, ça veut dire qu'il y a une charnière. Si il y a une charnière, ça veut dire qu'il y a un Hitchpoint, un point d'appui. Un point d'appui au départ qui est un peu mobile, mais si tu vas de plus en plus loin, ça devient un point fixe. Et bien ça c'est ton point de référence. Mais que tu dois suspendre à l'immobilité dynamique du système. Une deuxième question, est-ce que dans le méso-osophagien, y compris la veine cave ou pas ? Elle est très proche. Le cœur est assez... Tu vois, tu as même un axe. Tu as presque un axe. Un axe de la veine cave. Tu regardes le cœur. Donc il est très proche par rapport au niveau du foie. Il y a une petite distance entre la veine cave et le... Il nous a décrit le premier grand mouvement de la notocorde, et ce deuxième mouvement qu'on a vu hier dans ton petit film de champignons, de la cavité amniotique qui va faire le tour, donc un deuxième mouvement où ça part dans les deux sens, on pourrait dire que le centre de ce mouvement au niveau viscéral, est-ce que c'est au niveau du... C'est le cœur et le péritoine. Donc l'image c'est que tu t'enroules autour de ton système cardio pleuro péritoineal. Il faut vraiment voir ça comme une articulation. A la fois ton tube neural se développe très très fort vers l'avant, c'est lui qui amène le coeur, tu vois ici, mais derrière ton tube neural grandit aussi, c'est lui qui amène l'allantoïde par un champ de restriction sur le plan antérieur. Donc tu viens vers, tu viens te refermer comme ça, par ton pédicule

embryonnaire, tu fais ça. Donc tu ramènes tout. C'est vraiment cette image là, où on voit vraiment ici, et c'est là qu'on intègre son allantoïde, en même temps qu'on va intégrer le coeur. Ça devient un point d'appui. Mais à ce moment là, tu vas avoir deux choses importantes, c'est que tu vas avoir non seulement le coeur qui vient pousser sur la partie sud, mais aussi la partie supérieure de la vésicule viteline. Tu vois, tu pars, tu pousses. En poussant ça, ça oriente le tissu ici derrière, qui s'appelle le septum transaxle. Donc son origine était déjà là, si tu veux, les cellules étaient déjà là. Mais ça va l'orienter et l'organiser. Donc c'est la rencontre du cerveau sur le coeur, et du coeur sur la partie supérieure de la vésicule viteline, qui va donner l'impulse pour le tissu pour créer ton septum transaxle. Ça veut dire que le coeur, c'est une articulation entre le cerveau et le diaphragme.